

Y HỌC THỂ THAO ĐỈNH CAO ATP & WTA TOUR

Y HỌC QUẢN LÝ T: TI P C N TOÀN DI N

Tennis Medicine: A Complete Approach to Athlete Healthcare — Cơ sinh học chuỗi động học, bệnh lý khớp vai GIRD, Tennis Elbow và phác đồ trở lại thi đấu an toàn

TS. BS. Giovanni Di Giacomo (Trưởng Ban Y Tế ATP Tour)

L : D &

H

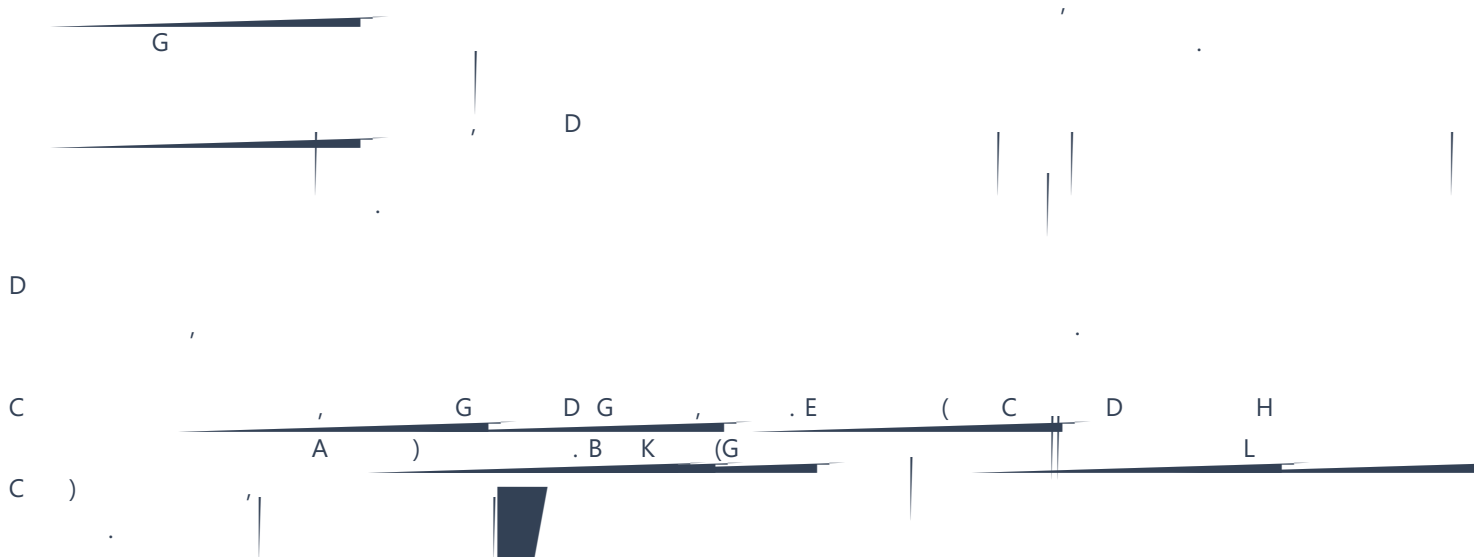
&

C

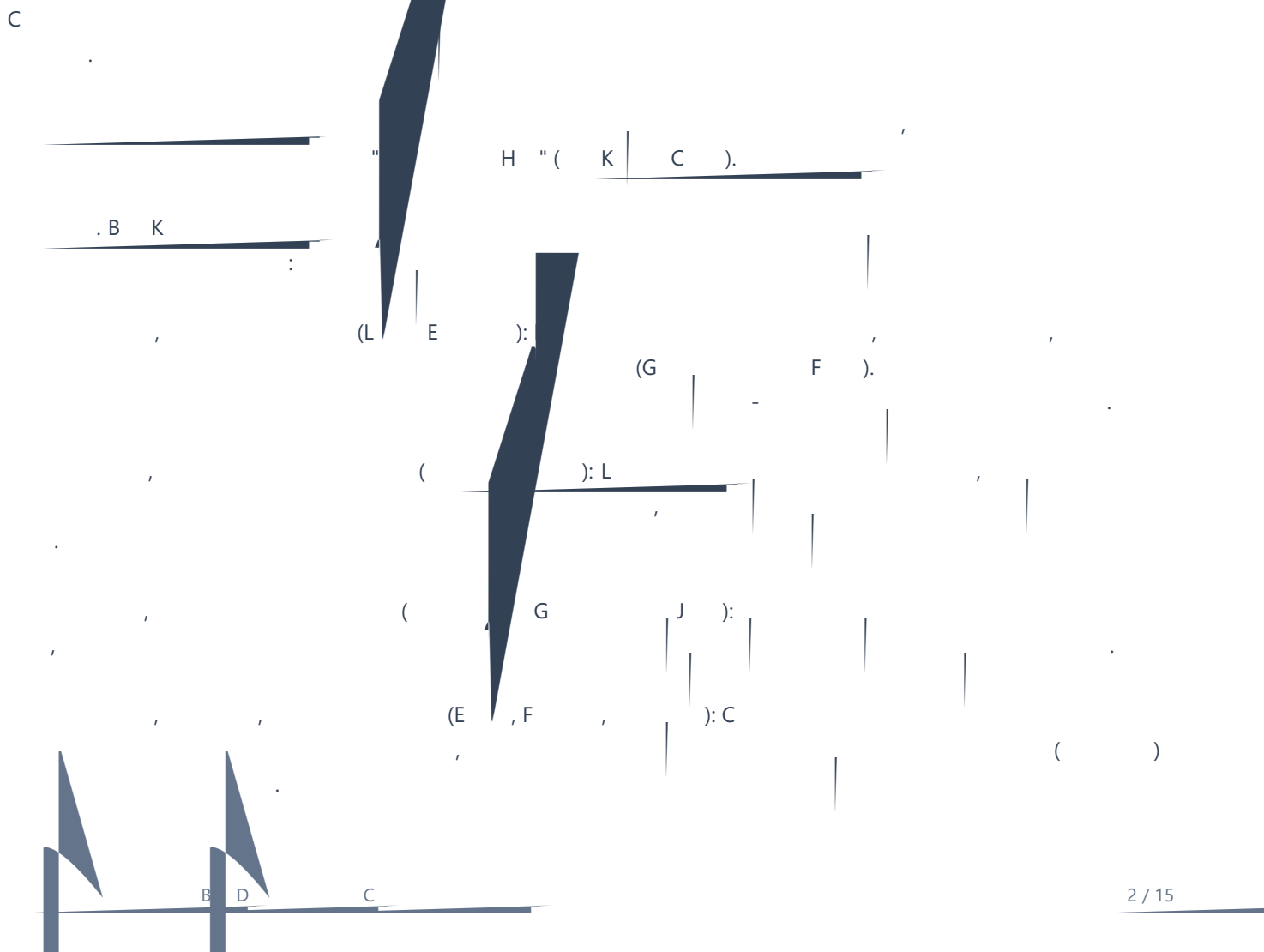
Phần I: Cơ Sinh Học Quấn Vết, Chuỗi Động Học & Dòng Chuyển Năng Lượng Cú Giao Bóng

Khảo sát y học đỉnh cao từ ban chuyên gia ATP Tour, cơ chế chuyển giao động lượng từ mặt đất qua các khớp và nguyên nhân gây quá tải chi trên

1. Lợi Ích Từ Novak Djokovic & Rafael Nadal: Sự Minh Bạch Về Hệ Cơ Thào Đỉnh Cao

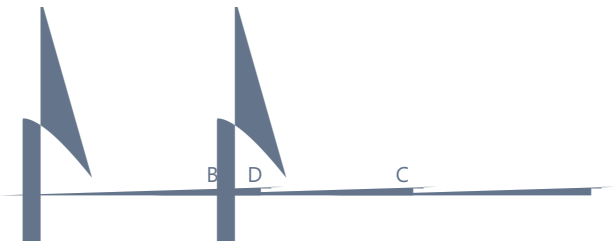
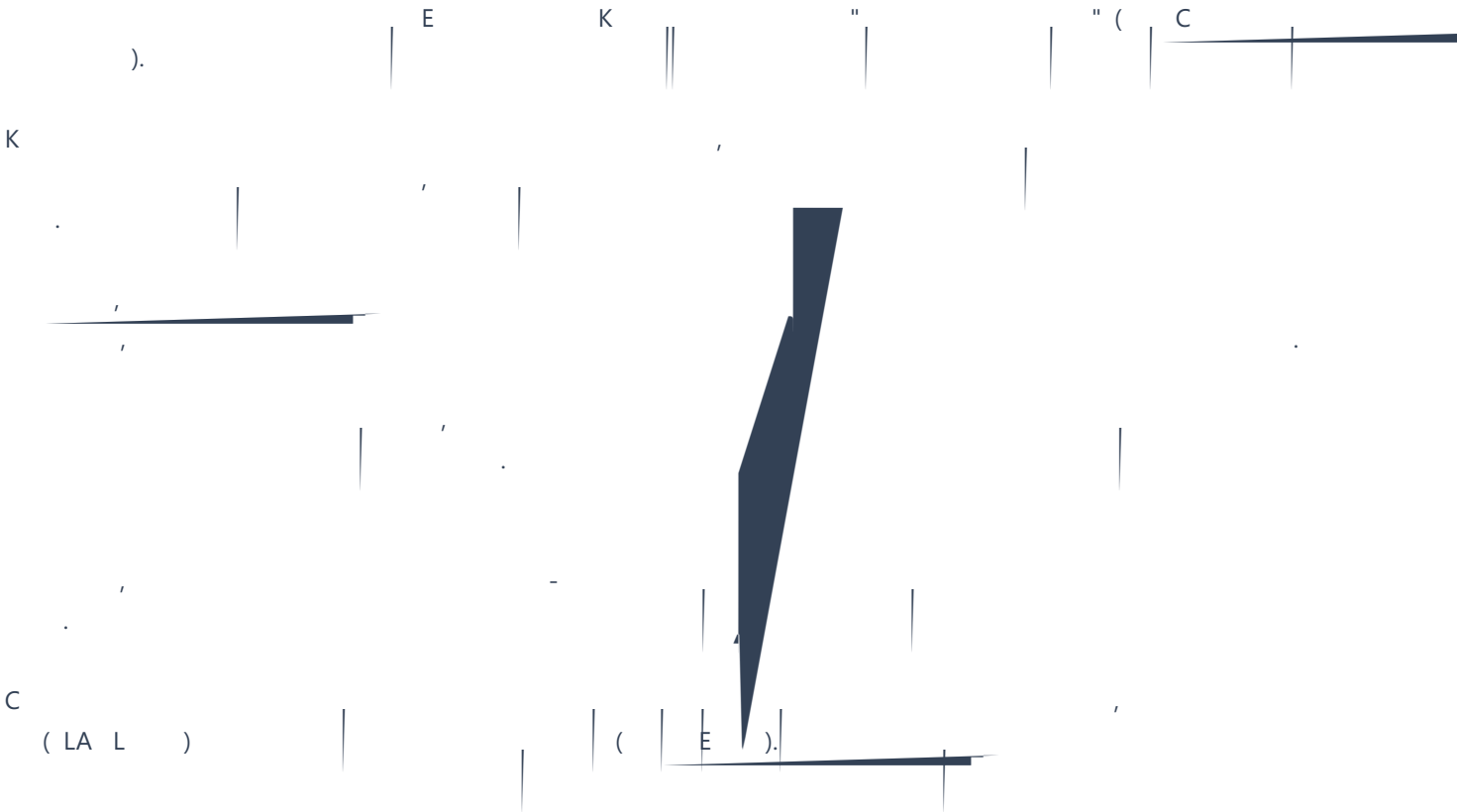


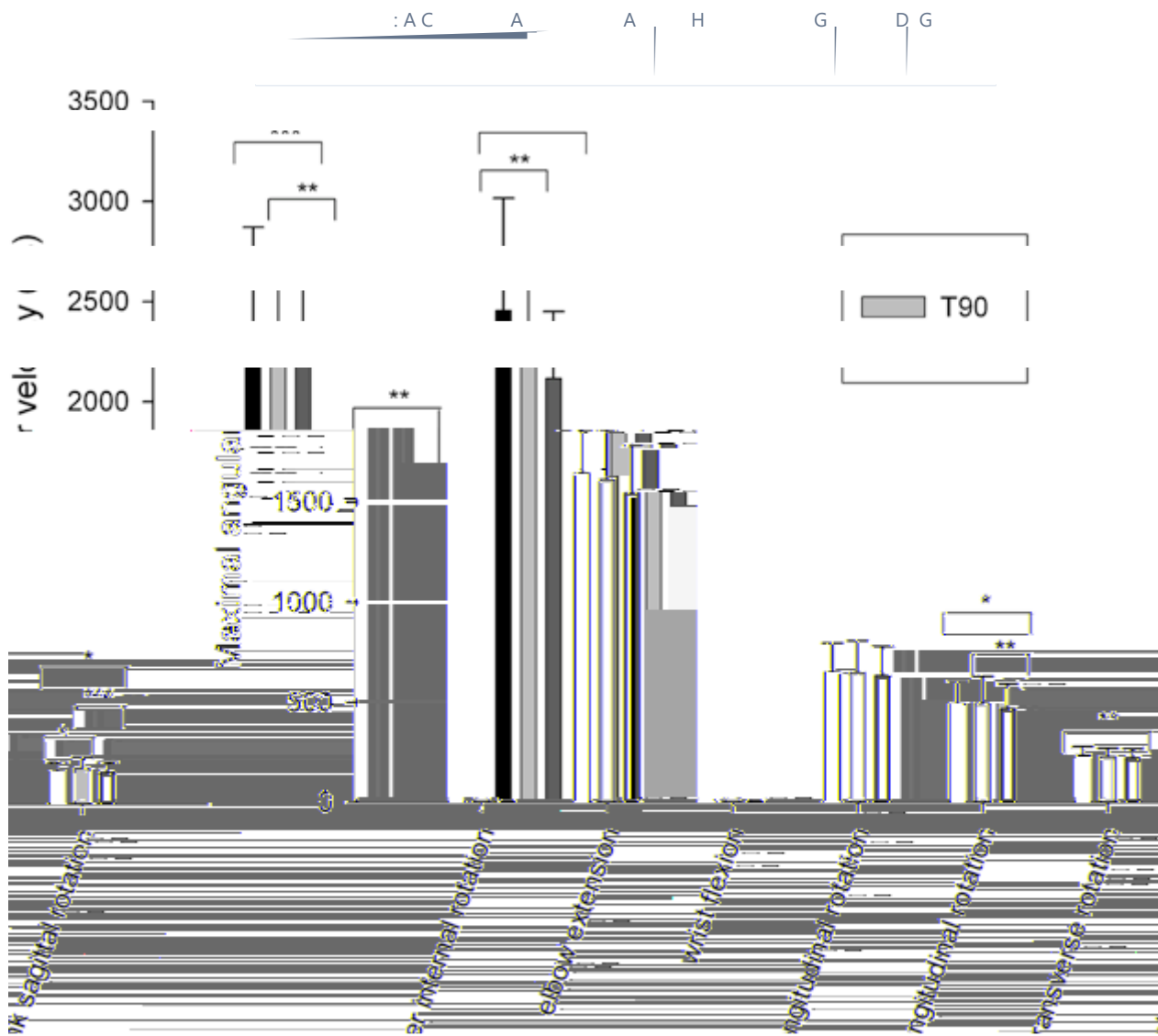
2. Cơ Sinh Học Cú Giao Bóng & Khái Niệm Chuỗi Động Học (The Kinetic Chain Concept)



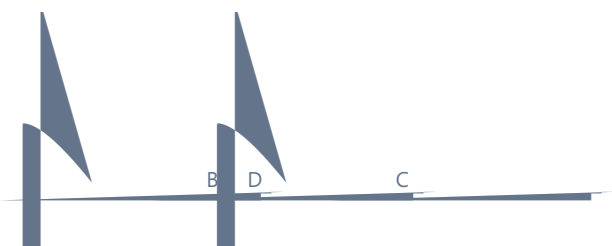


3. Dòng Ch y Năng Lư ng & H u Qu C a Đ t Gãy Chu i Đ ng (Energy Flow & Joint Overload)





H 1: (D G , E & K).

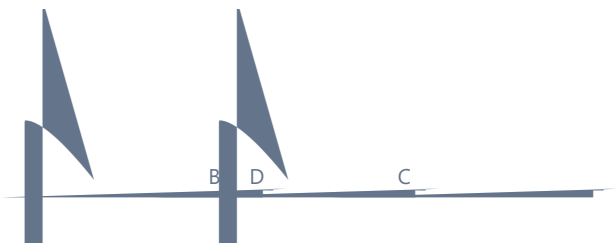


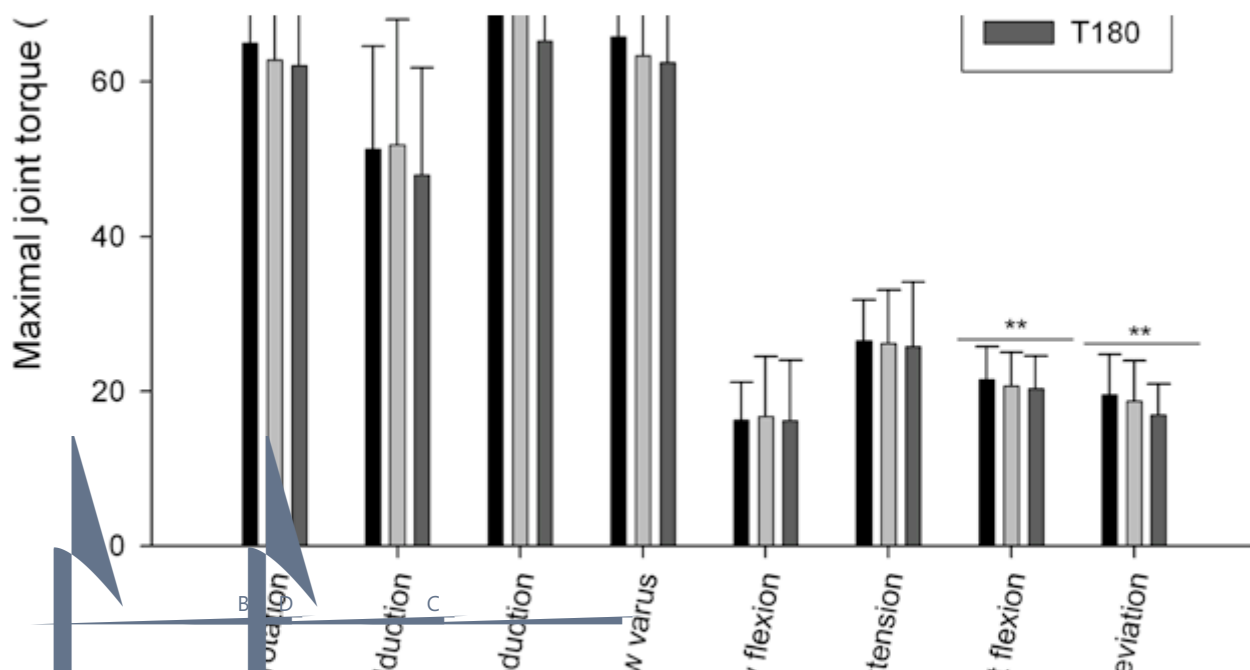
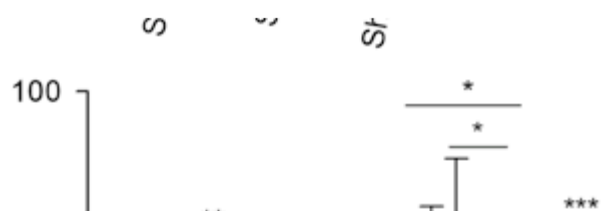
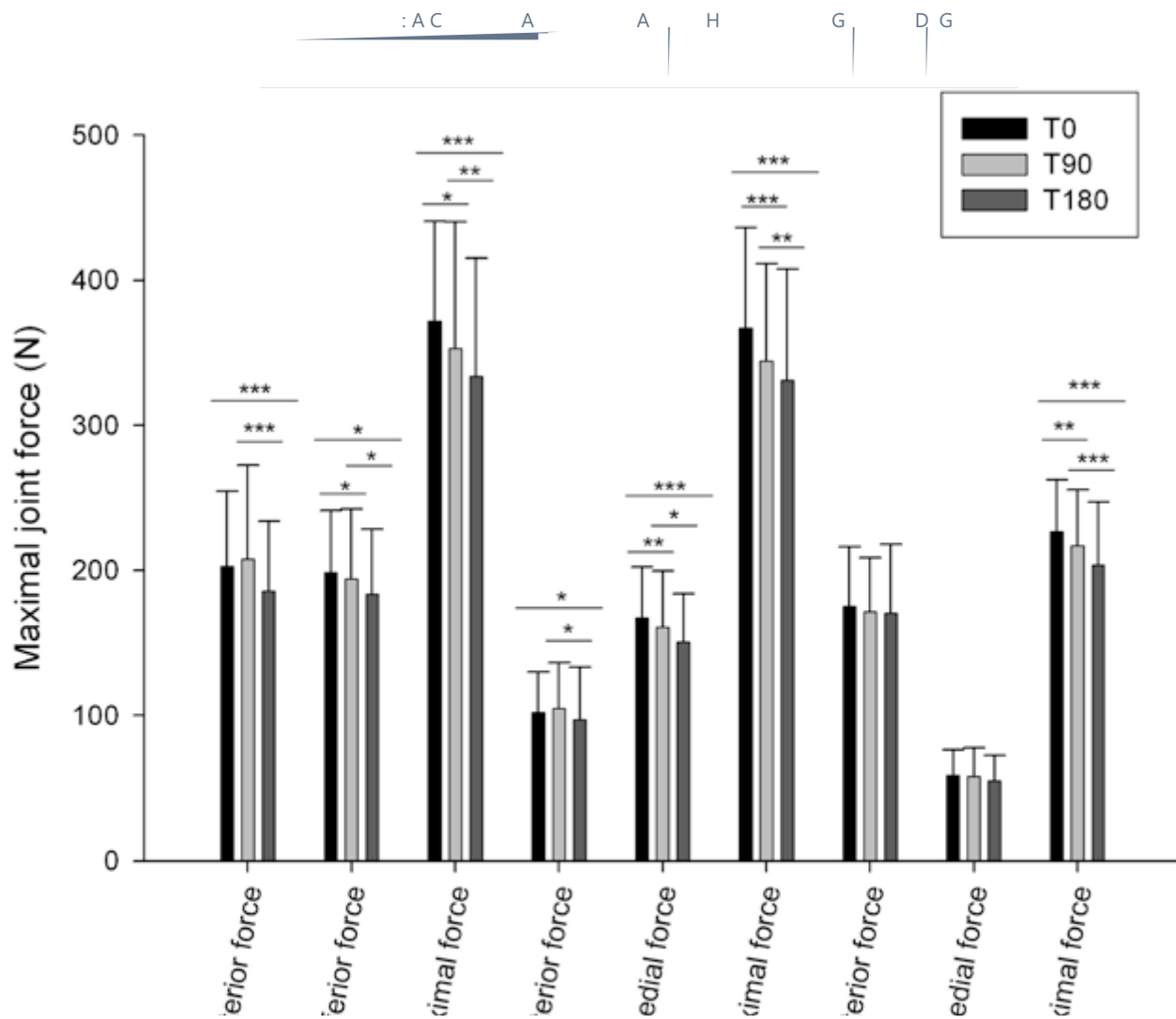
4. Vai Trò Của Tủy Xương Bả Vai & Hình Thức Rối Loạn Vận Động (Scapular Dyskinesia)



: AC A A H G D G

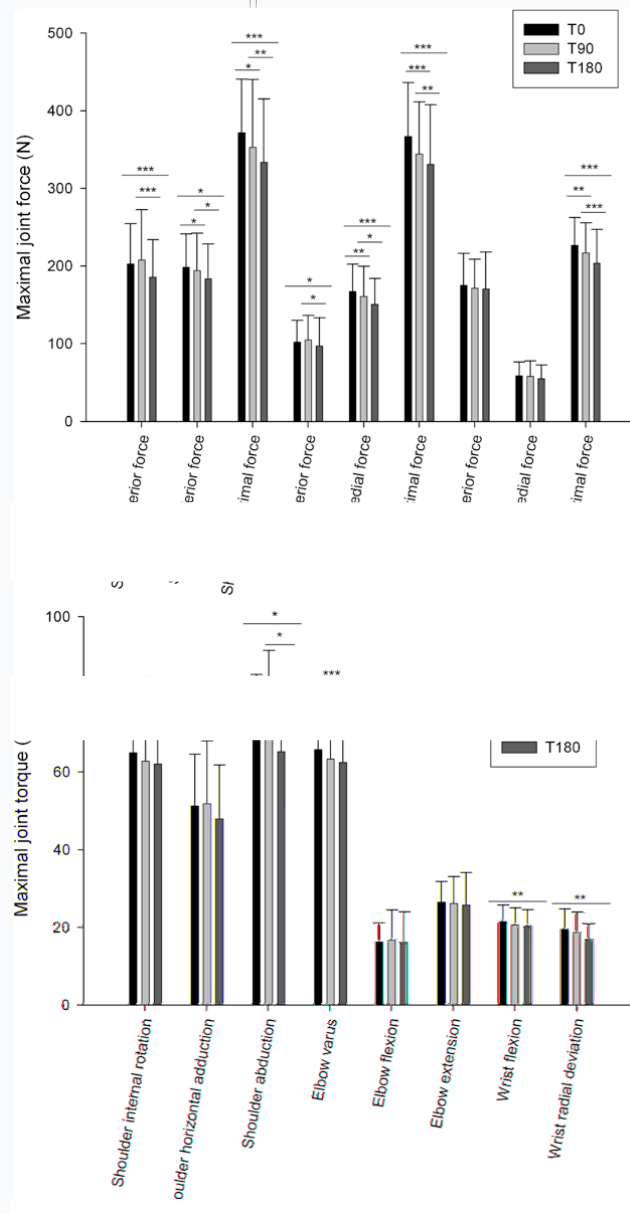
LA (L A): L





H 2:

(D G & E).



Hình 5: Hội chứng thâm hụt góc xoay trong khớp vai (Glenohumeral Internal Rotation Deficit - GIRD). Sự co rút bất cân bằng sau làm gia tăng nguy cơ rách sụn viền SLAP.

Phần III: Hội Chứng Khuỷu Tay Tennis Elbow, Chấn Thương Cổ Tay & Cột Sống Thoát Lưng

Bệnh học gân cơ duỗi cổ tay ngắn ECRB, tổn thương phức hợp đĩa sụn tam giác TFCC và gãy xương do mỏi cột sống thắt lưng

6. Cơ Chế Bệnh Sinh Của Hội Chứng Khuỷu Tay Tennis Elbow (Lateral Epicondylalgia)



: AC A A H G D G

H :

(FCC - F C): FCC

. K FCC,

(EC &): G EC

. C (EC),

K

(I),

L4 L5.

(C),

(C).



H 3: C /).

(



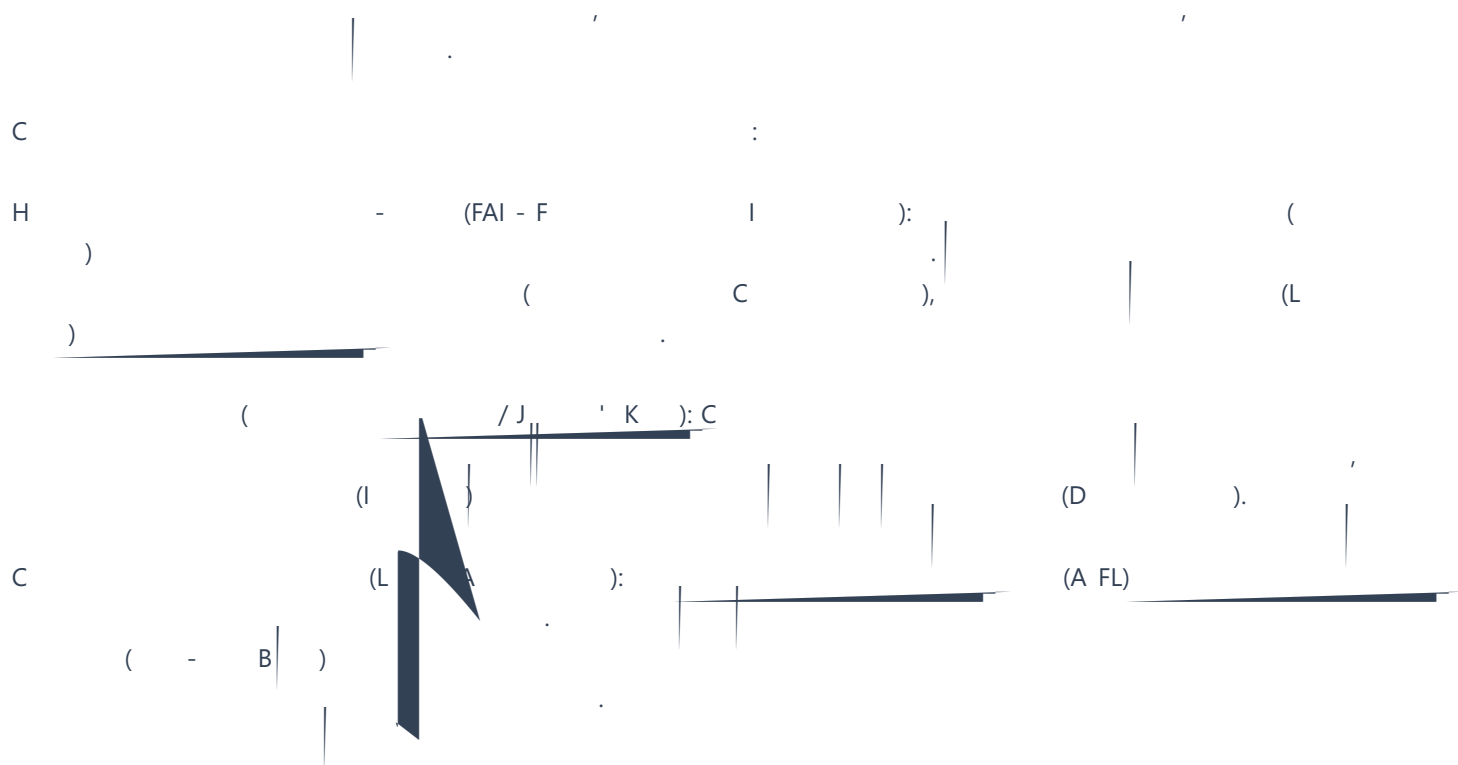
Hình 7: Cơ học quá tải cột sống thắt lưng (Lumbar Spine Biomechanics). Lực nén ép và xoắn vặn đốt sống L4-L5 trong tư thế uốn lưng phát bóng.



Phần IV: Chương Thương Chi Dự i, Y H c N i Khoa Qu n V t & Phác Đ Tr L i Thi Đ u

Hội chứng và chạm khớp háng FAI, sốc nhiệt thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt và quy trình năm giai đoạn trở lại sân đấu an toàn

8. Chương Thương Chi Dự i Đ c Thù: Kh p Háng, Đ u G i & C Chên



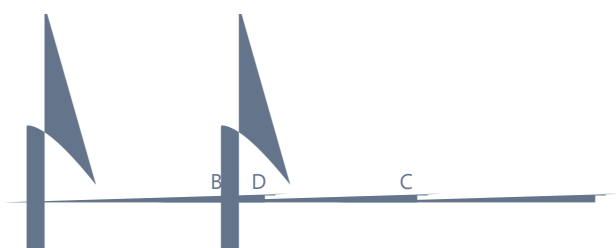
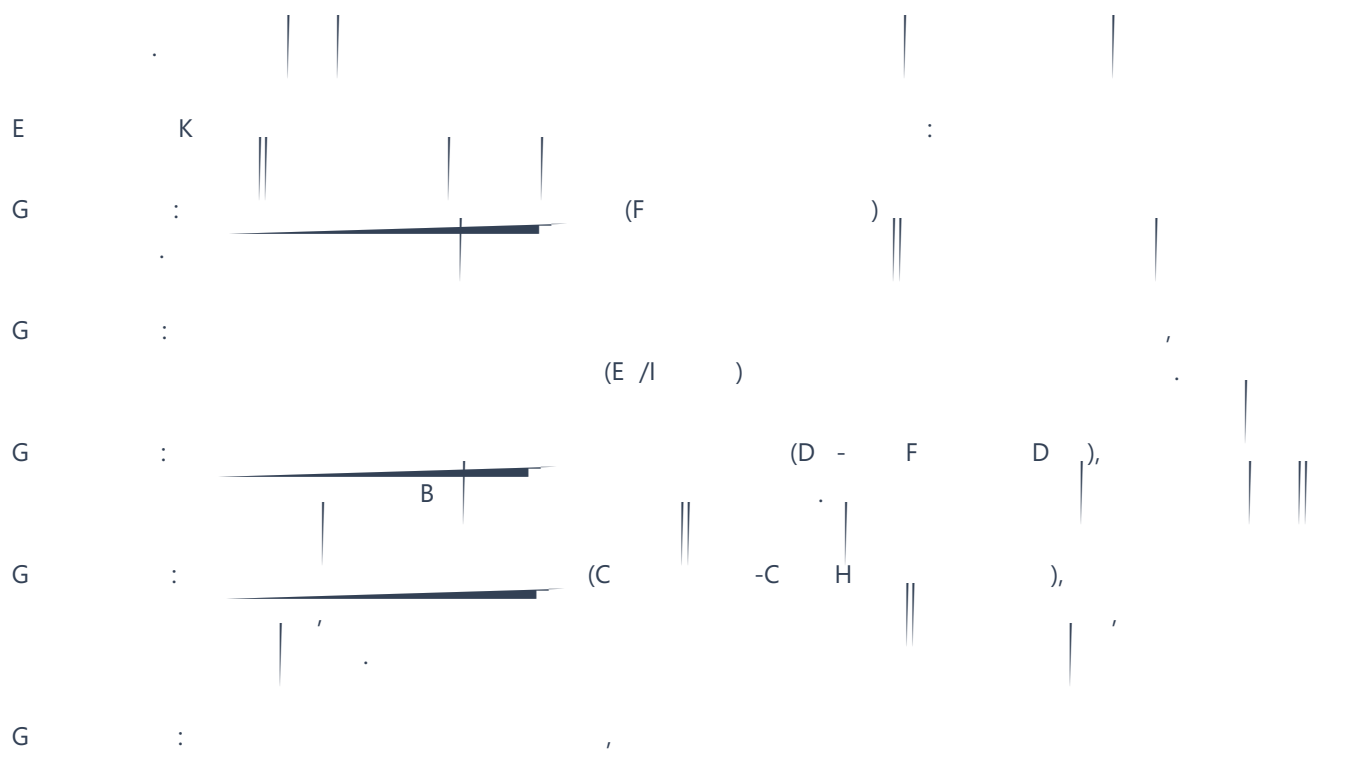


Hình 8: Chấn thương chi dưới đặc thù. Xung đột xương đùi - ổ cối (FAI), viêm gân bánh chè (Jumper's Knee) và lật mắt cá do lực hãm phanh đột ngột.

9. Y H c N i Khoa Qu n V t: S c Nhi t & Chi n Lư c Bù Đì n Gi i Thông Minh



10. Quy Trình Năm Giai Đo n Tr L i Thi Đ u An Toàn (Return-to-Play Progression)





Hình 9: Quy trình 5 giai đoạn trở lại thi đấu (Return-to-Play Progression). Phục hồi vận động cơ bản, nạp tải trọng thể lực, đánh bóng không đối kháng, đấu tập và trở lại giải đấu đỉnh cao.